

Procedimiento de reporte y análisis de incidentes

CÓDIGO	EVA-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y alcance

Registrar incidentes, eventos adversos y condiciones inseguras para prevenir recurrencia. El responsable es el fisioterapeuta. El reporte interno no sustituye tecnovigilancia ni otros reportes legales aplicables.

2 Detección y atención

Priorizar atención del paciente y controlar el peligro. Retirar del uso equipos o productos implicados conservando evidencia. Registrar hechos, lugar, hora y acciones sin alterar la historia clínica ni formular juicios sin análisis.

3 Registro y clasificación

Distinguir condición insegura, incidente sin daño y evento con daño según análisis. Identificar gravedad, posibilidad de recurrencia y necesidad de reporte externo. Usar identificador reservado del paciente; no colocar historias completas en carpetas administrativas abiertas.

4 Análisis

Reconstruir secuencia y revisar factores del paciente, tarea, equipo, entorno, comunicación y organización. Identificar barreras que fallaron o evitaron daño. Diferenciar asociación temporal de causalidad comprobada; recoger manuales, registros y entrevistas pertinentes.

5 Acción correctiva

Definir una acción concreta para cada causa o factor prioritario, responsable, fecha y evidencia esperada. Corregir el riesgo inmediato, pero no cerrar solo por capacitar si la causa requiere cambiar equipo, proceso o condiciones.

6 Comunicación y reporte externo

Informar al paciente hechos conocidos y conducta de seguimiento con respeto. Si interviene un dispositivo, aplicar ruta de tecnovigilancia: eventos o incidentes serios se reportan dentro de 72 horas de ocurrencia según regulación; los no serios tienen reporte periódico trimestral. Verificar canal oficial y conservar radicado.

7 Cierre y aprendizaje

Comprobar que la medida se ejecutó y redujo el riesgo mediante observación o revisión de registros. Documentar resultado, pendientes y cierre por nombre; mantener anonimización en análisis compartidos.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

EVA-F01 Reporte y análisis

Campo	Información
Identificador reservado fecha hora lugar	_____
Descripción factual y consecuencias	_____
Acción inmediata	_____
Factores y barreras identificados	_____
Reporte externo canal fecha radicado	_____
Acción responsable plazo	_____
Eficacia y cierre	_____

Lista de verificación interna

EVA-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Atención precede análisis	_____	_____
Hechos separados de opiniones	_____	_____
Factores y barreras revisados	_____	_____
Reporte externo cuando corresponda	_____	_____
Cierre con evidencia de eficacia	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia de reporte: Resolución 4816 de 2008 y Programa Nacional de Tecnovigilancia INVIMA.

https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minproteccion_4816_2008.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576